

NS

MARCOS DE MARTINO

IDADE: 61 PESO: 112 ALTURA: 176 PROFISSÃO: Gerente Inf. - Apes.
 SINTOMAS: Sonolência / Indisp. p/ exerc. / Dor cabeça.
 QUEIXAS: Dor garganta / rouco / tosse c/ pigarro.
 MEDICAMENTOS: Atenolol / Lisartana / sivasstatina

MÉDICO: Dr. Feralva
 EXERCÍCIO FÍSICO: não faz (fazendo dieta ↓ 9 Kg)
 HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 07:30 ALMOÇO: 12:30 LANCHE: 16 JANTAR: 19h
 HORA QUE DORME: 22h HORA QUE ACORDA: 6:30 Lanche (leite)
 COCHILHO () SIM (X) NÃO *as vezes* DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
 BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO *socialize fim semana*
 FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: *mista* BANHEIRO: 3 a 4x p/ ir banheiro
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
 OVERLAP: *não* MALLAMPATI: IV IAH: 62.1 SPO2: 88% med.
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS: SPO2: 68% min.
 CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA *negra*
 HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:
 COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA HAS
 (N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

14/08 Relata mudança de tom de voz.
 23 Adaptação do CPAP.

21/08 P = 11.1 perc. / 9.0 mediana
 23 IAH = 3.1 e/ev
 m. de uso: 7h44'
 Fuga = 12.9 l/min. *fua*
 Ouinto higiene do nariz.

04/09 P = 11.6 cmH₂O - 10.2 med. (5-11 cmH₂O)
 23 IAH = 3.0 Auto.
 m. uso = 7h5' (1x ao banheiro) *fua*
 Bem adapt.

20/09 P = 10 cmH₂O *melhora da dispon-*
 23 IAH = 2.1 *ção, após uso do CPAP.*
 m. de uso: 6h20' *a*

20/10 P = 10 cmH₂O *Bem adaptado.*
 23 IAH = 1.9 e/ev
 m. de uso: 5h48' *fua*
 Fuga = 12.2

29/11 P = 10 cmH₂O
 23 IAH = 2.0 e/ev
 m. de uso: 5h45'
 Bem adaptado *fua*

09/01 P = 10 cmH₂O
IAH = 1.9 e/h
M. de uso: 6h12'
Fuga = 10.9 l/min
Bem adapt. s/ queixas.
Relata que a sonolência
diurna e dor cabeça
fua

13/03
24 P = 9.9 cmH₂O
M. de uso: 6h33'
IAH = 2.2 e/h
Fuga = 11.1
s/ sonolência p/ dirigir
Bem adapt. s/ queixas.

10/06
24 P = 10 cmH₂O
IAH = 1.5 e/h
M. de uso: 6h27'
Fuga = 6.5 epm.
troca o filtro e bojo.
fua.

09/09
24 P = 9.8 cmH₂O
IAH = 2.5 e/h
M. de uso: 6h34'
Bem adaptado.
fua

09/12
24 P = 9.8 cmH₂O
IAH = 3.4 e/h
M. de uso: 6hs
Bem adapt. troca de acessórios e filtro
fua.

11/03/25 P = 9.8 cmH₂O
IAH = 3.3 e/h
M. de uso: 6h32'
Fuga: 17.8 l/min (pneum)
Bem adaptado
Natacha

16/06
25 P = 9.8 cmH₂O
IAH = 4.7 e/h
M. de uso: 6h24'
Fuga = 9.6 epm
troca a máscara.
nasal D. wear e filtro
fua.

Nome: MARCOS DE MARTINO

Data de Nascimento: 5-3-1962

IMC: 37,13

Sexo: Masculino

Data do exame: 24-07-2023

Peso: 115 kg

Altura: 1,76 m

Médico: DR. PERALVA DELGADO JUNIOR

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 24-07-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 535,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 50,5 e 132,5 minutos. O tempo total de sono foi de 360,5 min, eficiência de 67,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,2%; estágio N2: 73,1%; estágio N3: 1,2%; sono REM: 22,5%. O índice de despertares foi de 31,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 62,1/hora, sendo 30 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 139 hipopnéias. A SpO2 média foi de 88% e a mínima de 62%, permanecendo 36,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 54 - 90 bpm e NREM de 55 - 88 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (20), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 62,1/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=62%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

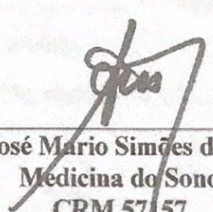
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57